心肌疾病 ★★★（0~3 题）

猝死（肥心病是青年运动猝死最常见的原因）：ICD 预防
房颤等心律失常、栓塞（附壁血栓脱落），病理 Q 波、ST 段压低、T 波倒置
超声心动图（2009、2012、2018、2023）

	肥厚型梗阻性心肌病（2009、2014、2022）	扩张型心肌病（2007、2012、2015、2017、2018、2021、2022）
病因	常染色体显性遗传（家族史）	病毒感染致免疫损害、遗传等
心脏特点	心室明显不对称肥厚 心室腔变小（左室显著）、左室舒张末压力↑ 左室流出道梗阻、SAM 征 “没血可射”	大：各心腔可扩大 —— 左室扩大最早最显著 心界常向两侧扩大 小：瓣口开放相对减小 薄：室壁变薄 弱：心肌收缩能力减弱、室壁运动普遍 / 弥漫减弱 “有血射不出”
临床特点	劳力性呼吸困难、胸痛、运动晕厥	左心衰（肺淤血水肿）或全心衰
心脏杂音	胸骨左缘 3~4 肋间收缩期杂音，常喷射样 杂音↑：强心苷、硝酸酯类、站位、Valsava 杂音↓：β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位卧位“蹲下、躺下” 心尖收缩期杂音	房室瓣反流：心尖 / 胸骨左缘 4~5 肋间收缩期杂音
所致心衰	主要是舒张性心衰（E/e’≥ 15、E/A ＜ 1.2）	收缩性心衰（LVEF ≤ 40%）
治疗	β-R 拮抗剂（首选，2009） 非二氢吡啶 CCB、丙吡胺、西苯唑啉“BBBB” 心肌肌球蛋白抑制剂玛伐凯泰 禁用强心苷、硝酸酯类	同慢性心衰，首选 β-R 拮抗剂 伴快速房颤可用强心苷

颈静脉怒张等体循环回流障碍，心界不大或稍大，舒张性心衰
超声心动图

	限制型心肌病	缩窄性心包炎
病因	淀粉样变等	结核、急性非特异性心包炎等
病理	心内膜心肌纤维化	心包粘连增厚、钙化
体征	无奇脉（2012）	可有奇脉、心包叩击音（特点）、负性心尖搏动、室间隔抖动征

病毒性心肌炎

1~3 周感染病史（发热、咽痛、消化道症状等）
随后可胸痛、左心功能不全，心悸与体温不相称，严重者休克、钟摆律“酷似心梗”（2021）

可能可能最可能（2012、2020）

金标准：心肌活检（柯萨奇 B 组病毒等）
病理 Q 波、心肌坏死标志物（cTn、CK-MB）↑